Signature Not Verified
Digitally signed by Medis UKC MAribor

Oddelek za psihiatrijo

MARIBOR, 19.07.2022

ODPUSTNO PISMO

DRAUČBAHER PETER
OŽBALT 53

2361 OŽBALT

Rojen-a	17.09.1984	KZZ: 040003336
Reg.št.	5025068692	
Podjetje	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVARO	
Dodat.zav.		
Zap.štev.	681226 4	
Matična št.	998084	
Velj.nap.	**10.03.2021**	**Obseg poobl. 1,2,3**

Datum, ura sprejema	*Dat.,ura adm.odp.*	*Št. hospital. dni*
10.03.2021 20:10	29.04.2021 07:05	50

Datum in ura odpusta: 29.04.2021 07:15 *Merilo ustreznosti sprejema:* 18

Sprejemni zdravnik: PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije
Sobni zdravnik: PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije
Predstojnik oddelka za psihiatrijo: JURE KOPRIVŠEK, dr. med., spec.psihiatrije

DIAGNOZA

23.04.2021 - F2331 Akutna psihotična motnja
23.04.2021 - F601 Shizoidna osebnostna motnja
23.04.2021 - S4200 Zlom desne ključnice (inveter.)

ANAMNEZA IN STATUS OB SPREJEMU

Bolnik je zvečer pripeljan z reševalnim vozilom iz psihiatrične klinike Ljubljana Polje. Priložena napotnica akutna in prehodna psihotična motnja in pripis, da je preusmerjen zaradi regijske pripadnosti. V urgentni ambulanti v Ljubljani je prejel Lorsilan 1 mg per os, preizkus alkoholiziranosti je bil negativen. Priložen tudi današnji ambulanti karton, s katerega je razvidno, daj je prišel v Polje z bratom, ki je opisal stanje (glej priložen zapis v dokumentaciji). Navajajo, da je bil bolnik že dvakrat v kratkem pregledan pri njih, vendar hospitalizacije ni želel, sedaj si je premislil. Opisujejo hud strah, da se bo nekaj hudega zgodilo in občutke, da ga nekdo zasleduje. O tem ni želel govoriti, navajal je težave s čutenjem in prostorsko predstavo.

Bratov priloženi opis funkcioniranja:
Naj bi imel blodnje, preganjavico, halucinacije in luknje v spominu, pozabljal stvari in izgubil vse dokumente, avto, denarnice, ključe in podobno. Šel naj bi v Avstrijo in v Izolo, dobil neko kazen zaradi kršitve policijske ure in se obnaša nenavadno, »neprištevno«. Bratu naj bi navajal, da ga lovi policija, da ga hočejo uničiti, v službi naj bi dal odpoved in uničil sim kartice. Menda naj bi poskušal samomor z alkoholom (izčrpali naj bi mu želodčno vsebino pred kratkim).

Bolni je ob prihodu v našo urgentno ambulanto umirjen in sodelujoč. O predhodno opisani psihopatološki simptomatiki ne želi govoriti. Navaja, da bi rad to preseka, da je imel čudne občutke, o katerih ne bi govoril. Govori splošno, o nesporazumih, o konfliktih, direktno povprašan potrdi pretekle suicidalne namere (naj bi za to zaužil veliko alkohola), vendar trenutno naj ne bi imel nobenih samomorilnih nagnjen. Navaja, da ne želi biti nekdo, ki je večkrat pobegnil iz Polja, zato se je danes odločil, da v bolnišnici ostane, pa so ga preusmerili sem. Nenavadno naj bi se počutil približno mesec dni, v tem času se je preselil na mamin bivši dom (iz Ljubljane v Ožbalt). V zadnjem mesecu zaradi korone dela od doma, potrdi, da je dal odpoved, vendar meni, da je še zaposlen. Po izobrazbi je pomorski tehnik, v tem poklicu

ni delov, dela kot računalničar. Direktno povprašan po paranoidnih in halucinatornih doživetij na odgovori.

Telesno naj bi bil zdrav, tudi sicer v družini naj ne bi bilo duševnih bolezni, ne uživa alkohola (razen kot omenjeno pred dnevi) in ne uživa drog. Je samski. Ima brata, ki ga je danes pospremil na kliniko v Polju in mamo. Na vprašanje, kako se razumejo, ne odgovori. Očeta ni poznal.

Opiše, da se je v Ljubljani obakrat prestrašil, enkrat zato, ker so pripeljali invalidski voziček, drugič pa posteljo, zato je iz ambulante pobegnil.

Psihični status:
luciden, tudi lepo pogovorljiv, precej kontroliran, ne odgovarja na ciljna vprašanja po psihopatologiji, trenutno je kar sproščen (v Polju opisan kot napet in vznemirjen), prav tako je duktus koherenten, je pa precej psevdofilozofski in okolišev, in glede na heteroanamnestične podatke disimulira preganjalno nanašalne vsebine, suspektno pa tudi zaznavne motnje. Razpoloženje ni pomembno znižano ali privzdignjeno, prepričljivo je brez avto in heteroagresivnih tendenc in se strinja s hospitalizacijo.

Bolnika s soglasjem sprejmem na Covid enoto z namenom odvzema brisa na SARS-CoV-2. Uvedem nižji odmerek lorazepama in risperidona ter hipnotik po potrebi.

Nekaj minut po sprejemu pokliče brat, gospod Marko, preverja, če je Peter prišel do nas, za več informacij bo poklical jutri.

DG: F23.90.
/bš

IZVIDI MEDODDELČNIH OBRAVNAV

FE: 421 Laboratorij nuklearne medicine
Datum, ura obravnave: **11.03.2021 09:52**
Zdravnik: prim. MITJA TOPALOVIČ, dr. med., spec. internist

FE: 822 Ambulanta za CT diagnostiko
Datum, ura obravnave: **18.03.2021 09:58**
Zdravnik: BENO POLANEC, dr. med., spec. radiolog

Napotna diagnoza: Diagnostika prve psihoze

CT glave brez KS:

Prepričljivih znakov za sveže demarkirane postishemične spremembe, krvavitev ali ekspanzivni proces ne vidim.
Ventrikularni sistem je simetričen, primerno širok, brez pomikov možganovine.
Bazalne cisterne se dobro diferencirajo.
V zadnji kotanji ne vidim posebnosti.
V področju orbit, obnosnih votlin in hipofize prepričljivih patoloških sprememb ne vidim.
Pnevmatizacija mastoidnih celic je ohranjena.

Mnenje:
Današnji izvid je v mejah normalnega.

FE: 820 Ambulanta za RTG diagnostiko
Datum, ura obravnave: **25.03.2021 09:08**
Zdravnik: MARKO EINFALT, dr. med.

Napotna diagnpoza: Star zlom ključnice?
Medis: Poškodba desne klavikule pred enim letom.

RTG desne ključnice:

Starih slik za primerjavo nimam.
Zlom srednjega dela desne ključnice z večjim premikom odlomka. Distalni del klavikule je premaknjen navzdol za 12 mm. Robovi klavikule na mestu preloma so gladki - najverjetnje stanje po starejši frakturi. 5 cm od AC sklepa je v ključnici vidna sklerotična sprememba - najverjetneje kostni kalus starejše frakture.

FE: 052 Travmatološka ambulanta 1-dopoldan
Datum, ura obravnave: **01.04.2021 09:00**
Zdravnik: prim. ALEKSANDER FRANK, dr. med.

Prihaja na konzilijarni pregled s psihiatrije. Tam se zdravi zaradi psihoze. Pred enim letom si je zlomil desno ključnico, takrat večje pozornosti temu ni namenjal. Sedaj pa opaža, da ima pri fitnesu težave v smislu bolečin v predelu desne ključnice.

ST.: v predelu desne ključnice se tiplje deformacija. Klinično odlomka ne izgleda čvrsta, se gibljeta vsak zase. Prosk. nekoliko pritiska na kožo.

RTG kontrola: gre za stanje po zlomu desne ključnice, ki je v prikrajšavi za cca. 2 cm in v dislokaciji adlatus tudi za pribl. 1,5 cm, v okolici vidnih nekaj senc kostne gostote - kalus, ki pa ne dosega obeh odlomkov in fraktura verjetno ne zarašča.

MNENJE: zaradi natančnejše diagnostike je potrebno še narediti CT d. ključnice.

Naša kontrola z izvidom.

FE: 820 Ambulanta za RTG diagnostiko
Datum, ura obravnave: **01.04.2021 09:28**
Zdr.delavec: Benjamin ŠVEC,dipl.inž.radiol.

FE: 822 Ambulanta za CT diagnostiko
Datum, ura obravnave: **06.04.2021 08:27**
Zdravnik: doc.dr. MITJA RUPREHT, dr. med., spec.radiolog

Klinični podatki: Nezaraščanje zloma desne ključnice.

CT desne ključnice:

Brez znakov preraščanja zloma ključnice v srednjem delu z večjo dislokacijo. Anteriorno pred zlomom 2,5 cm dolg trakast priostren kostni fragment, ob njem še nekaj drobcev.

Brez sprememb ostalega prikazanega skeleta.

FE: 052 Travmatološka ambulanta 1-dopoldan
Datum, ura obravnave: **08.04.2021 10:46**
Zdravnik: TOMI KUNEJ, dr. med.

Prihaja na konziliarni pregled s psihiatrije. Pri nas obravnavan zaradi non union zloma desne ključnice. Opravil je CT, ki potrdi nezaceljen zlom desne ključnice.

Mnenje: pacienta bom predstavil na konziliju Oddelka za travmatologijo. O mnenju konzilija bo pisno obveščen.

FE: 052 Travmatološka ambulanta 1-dopoldan
Datum, ura obravnave: **12.04.2021 13:00**
Zdravnik: TOMI KUNEJ, dr. med.

Pacient je bil predstavlje na travmatološkem konziliju, ki je mnenja, da je indicirana operativna terapija, osteosinteza in eventuelna spondioplastika. Pogovorim se tudi z lečečim psihiatrom dr. Zamudo, ki je mnjenja, da bo pacient perioperativno in pooperativno sposoben sodelovati.

Pri pacientu odvzamite laboratorijske preiskave, KKS, ELEKTROLITI, RETENTI, določite KG, posnamite EKG. Opravi naj konziliarni pregled pri anesteziologu. Pred premestitvijo naj ima tudi opravljen bris na Covid-19. Ko bodo vse preisakve opravljena, se za premestitev dogovorite z glavno sestro travmatološkega oddelka na 1345.

FE: 251 Enota za anesteziologijo
Datum, ura obravnave: **26.04.2021 11:00**
Zdravnik: DENIS SRAKA, dr. med.

MNENJE: Po pregledu dokumentacije ugotavljam, da gre za 36-letnega pacienta hospitaliziranega na Oddelku za psihiatrijo zaradi psihode (v remisiji), ki bo operiran zaradi eno leto starega zloma ključnice. Pri pacientu gre za shizoidno osebnostno motnjo, ki se vodi pri psihiatru, drugače je pacient brez drugih znanih pridruženih bolezni. Trenutna terapija: Risperdal 2-0-3mg, Lorsilan 0,5-0-1mg. Alergije niso znane.

Laboratorijski izvidi in koagulacija so v mejah normale. Za predoperativni klinični pregled prosim anesteziologa pristojnega za operativni poseg.

Za operativni poseg svetujem rezervacijo dveh enot koncentriranih eritrocitov. Pred operativnim posegom naj prejme Risperdal 2mg tbl in Dormicum tbl 7,5mg tbl.

Prepis izvidov
Peter Draučbaher, rojen 17.09.1984
Datum pregleda: 16., 17. in 22.03.2021

Na kliničnopsihološki pregled, ki je bil opravljen med hospitalizacijo na A1 (enota za intenzivno psihiatrično zdravljenje), ga je napotil asist. Tilen Zamuda, dr. med., spec. psih.

Napotna diagnoza: prva psihoza, osebnostna patologija

Anamneza:
V bolnišnici je pristal po spletu okoliščin. Imel je panični napad, prestrašile so ga stvari, ki jih je videl. Imel je čuden občutek, opazil je, da so stvari doma narobe postavljene in da ga ljudje ne marajo. Pobegnil je v Graz, kjer je hodil po mestu, nato je parkiral avto, vrgel ključe in osebno izkaznico v smeti ter se s taksijem pripeljal nazaj v Slovenijo. Čez nekaj dni se je ponovno prestrašil, strah ga je bilo maščevanja mame. Ta bi se mu naj maščevala zato, ker je toliko let zanemarjal čustva in preživel toliko časa za računalnikom. V bolnišnico je prišel, ker ne more živeti kot pobegli zapornik iz Polja. Brat ga je namreč med temi dogodki dvakrat odpeljal k psihiatru, vendar se ni strinjal s hospitalizacijo. Zdaj išče odpustek s strani zdravstva, da lahko normalno zaživi. Pred tem dogodkom se je v redu počutil, nikoli ni imel

podobnih težav. Pred nekaj meseci se je vpisal na tečaj salse, reče, da zato, ker ni želel biti večno sam. Spoznal je punco, ki ni bila partnerka. Takrat ni zmogel prepoznati socialnih vzorcev, zdaj te vzorce predeluje za nazaj v svojih mislih in mu ni všeč kar vidi. Do zdaj še ni imel nobene resne partnerske zveze, ker ni veliko dal na odnose, prav tako ni veliko čutil. Sočloveka ni začutil, ni imel empatije. Zaradi tega ima tudi šibko socialno mrežo. Zdaj pogreša odnose, ampak, če se ne bo naučil brati socialnih vzorcev, tudi odnosov ne bo mogel imeti.
Do pred nedavnim je živel z mamo in bratom v Ljubljani, zdaj se je preselil v mamino hišo v Ožbaltu, kjer živi sam. Očeta ni poznal, saj živi v Teheranu. Glede zgodnjega razvoja in otroštva pove, da ima težave s težo že od 6. leta starosti in da zato tudi nikoli ni imel prijateljev. V šoli ni imel nikoli težav, učno snov si je zapomnil z lahkoto, večje težave je imel pri vključevanju v družbo. Tako je bilo nato tudi v srednji šoli in na fakulteti.
Zaključeno ima srednjo šolo, smer pomorstvo, nato je na FERI-ju študiral programsko opremo, vendar študija ni zaključil. Ima 10 let delovne dobe, zdaj je delal kot programer. V službo se ne želi vrniti, saj so odnosi tam skrhani. V službi naj ne bi želeli, da bi v času epidemije covid-19 delal od doma, on pa je vztrajal. Sicer so popustili, vendar so nastale zamere.

Opis vedenja: Pacient prihaja na pregled urejen, pri pregledu ustrezno sodeluje, v socialni kontakt ustrezno vstopa. V pripovedi je koherenten in primerno obširen, pripoved samostojno razširja. Mišljenje je po vtisu formalno urejeno, v vsebinskem smislu pa so prisotne svojske razlage situacij. Čustvovanje je razgibano, ustrezno kontrolirano in situacijsko odzivno. Za reševanje psihodiagnostičnih preizkušenj je ustrezno motiviran, enostavna in kompleksna navodila k nalogam razume in jih ustrezno vzdržuje.

Pri psihološkem pregledu so bila poleg intervjuja uporabljena naslednja psihodiagnostična sredstva: Rorschachov preizkus (Ro.p.) in Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI).

Povzetek rezultatov:

Ocena osebnosti, vedenja in čustvovanja:
Profil na samoocenjevalnem vprašalniku za oceno osebnosti je veljaven in primeren za interpretacijo. Pomembno povišane klinične lestvice nakazujejo, da gre za socialno umaknjenega posameznika, ki je v odnosih precej nezaupljiv. Težave ima s prepoznavanjem in razlago normalnih odtenkov medosebnega vedenja, zlasti čustvenih izrazov. Ne glede na preteklost se sprašuje o pristnosti namenov ljudi, ki ga obkrožajo in dvomi vanje, prav tako hitro dobi občutek, da ga drugi obravnavajo nepravično. Poroča tudi, da so njegovi odnosi nestabilni in ambivalentni, trenutno čuti užaljenost in občutek izdaje. Pomembno povišane lestvice obravnave kažejo, da trenutno doživlja zmerno stopnjo stresa, ki pomembno vpliva na njegovo vsakodnevno funkcioniranje, ob tem pa čuti, da iz svojih socialnih odnosov dobi le malo podpore oziroma mu predstavljajo vir konflikta.
Veljaven zapisnih na izvedbeni meri osebnosti nakazuje na pacienta, ki reakcije na čustvene dražljaje modulira s kognitivno kontrolo ali jih ignorira. Pretirano se zanaša na logiko in omejevanje ter se težje sprosti. Ob tem pa so prisotne težave z realnim zaznavanjem, nakazuje se ranljivost za psihotična stanja. Realitetna kontrola je motena. V odnosu do drugih se kaže netipično oziroma popačeno razumevanje ljudi. Prisotna je preokupiranost s prepričanji, ki motijo realno ocenjevanje ter razumevanje misli in dejanj drugih ljudi.

Mnenje:
Pri 36-letnem pacientu, ki je prvič hospitaliziran na oddelku za psihiatrijo, na podlagi kliničnopsihološkega pregleda ugotavljamo, da gre v osnovi za osebnostno patologijo in posledično za psihotično dekompenzacijo ob stopnjevanju tako situacijskih stresorjev kot notranjih konfliktov.

Trenutno je v ospredju preokupacija z odnosi in socialnimi stiki, pri čemer je prišlo, pri sicer socialno umaknjenem in socialno manj spretnem gospodu, do čustvenega preplavljanja in posledično do izgube realitetne kontrole. Gre za gospoda, ki ima le malo socialnih stikov, v odnose vstopa nezaupljivo in previdno. V odnosih je nato hitro prizadet in ima občutek, da se mu godi krivica, zato se jim večinoma izogiba. Njegovo razumevanje socialnih interakcij ter njegove razlage misli in dejanj drugih ljudi so idiosinkratične in pogosto netočne, njegovo procesiranje čustev je izrazito kontrolirano in omejeno, doživljanju in procesiranju čustev se večinoma raje izogne. Aktualno doživlja hud stres, ki ga ne zmore

obvladovati. Pričakovati je, da bo tudi v prihodnje ob stresnih situacijah, ki vključujejo socialne situacije, odreagiral z izgubo realitetne kontrole.

Sara Plakolm, univ. dipl. psih., specializantka klin. psih./sp

Mentorica: asist. mag. Borjana Kremžar Jovanović, univ. dipl. psih., spec. klin. psih./bkj

/DG

ZAKLJUČEK

36-letni bolnik je bil na sprejem pripeljan z reševalnim vozilom iz Psihiatrične klinike Ljubljana Polje. Priložena napotnica akutna in prehodna psihotična motnja in pripis, da je preusmerjen zaradi regijske pripadnosti. V urgentni ambulanti v Ljubljani je prejel Lorsilan 1 mg per os, preizkus alkoholiziranosti je bil negativen. Priložen tudi današnji ambulanti karton, iz katerega je razvidno, daj je prišel na CMZ v Ljubljani z bratom, ki je podal heteronamnestične podatke. Navajajo, da je bil bolnik že dvakrat v kratkem pregledan pri njih, vendar hospitalizacije ni želel, sedaj si je premislil (pac. opiše, da se je v Ljubljani obakrat prestrašil, enkrat zato, ker so pripeljali invalidski voziček, drugič pa posteljo, zato je zato je iz ambulatne pobegnil). Opisujejo hud strah, da se bo nekaj hudega zgodilo in občutke, da ga nekdo zasleduje. O tem ni želel govoriti, navajal je težave s čutenjem in prostorsko predstavo.

V Medisu je zabeležena obravnava v Urgentnem centru MB dne 21.2.2021, ko je bil pripeljan vinjen (etanol v serumu 1,3 g/l), menda naj ne bi imel encimov za presnovo alkohola, napil naj bi se iz samomorilnih namenov, UC je zapustil pred zaključkom obravnave, proti nasvetu zdravnika.

Bolnik je bil ob prihodu v našo urgentno ambulanto umirjen in sodelujoč. O predhodno opisani psihopatološki simptomatiki ni želel govoriti. Navajal je, da bi rad to prekinil, da je imel čudne občutke, o katerih ne bi govoril. Pripovedoval je splošno, o nesporazumih, o konfliktih, direktno povprašan je potrdil pretekle suicidalne namere (naj bi za to zaužil veliko alkohola), vendar trenutno naj ne bi imel nobenih samomorilnih nagnjen. Navaja, da ne želi biti nekdo, ki je večkrat pobegnil iz Polja, zato se je danes odločil, da v bolnišnici ostane, pa so ga preusmerili sem. Nenavadno naj bi se počutil približno mesec dni, v tem času se je preselil na mamin bivši dom (iz Ljubljane v Ožbalt). V zadnjem mesecu zaradi korone dela od doma, potrdil je, da je dal odpoved, vendar meni, da je še zaposlen. Po izobrazbi je pomorski tehnik, v tem poklicu ni delal, dela kot računalničar. Direktno povprašan po paranoidnih in halucinatornih doživetij ne odgovori.
Telesno naj bi bil zdrav, tudi sicer v družini naj ne bi bilo duševnih bolezni, ne uživa alkohola (razen kot omenjeno pred dnevi) in ne uživa drog. Je samski. Ima brata, ki ga je danes pospremil na kliniko v Ljubljani in mamo. Na vprašanje, kako se razumejo, ni odgovoril. Očeta ni poznal.

Psihični status ob sprejemu: luciden, pogovorljiv, a precej kontroliran, ne odgovarja na ciljna vprašanja po psihopatologiji, trenutno je kar sproščen (v Polju opisan kot napet in vznemirjen), prav tako je duktus koherenten, je pa precej psevdofilozofski in okolišav, in glede na heteroanamnestične podatke disimulira preganjalno nanašalne vsebine, suspektno pa tudi zaznavne motnje. Razpoloženje ni pomembno znižano ali privzdignjeno, prepričljivo je brez avto-in heteroagresivnih tendenc in se strinja s hospitalizacijo.

Na oddelku je bil bolnik sprva nezaupljiv, distanciran, iznašal je paranoidne blodnjave vsebine napram svojcem in spremenjeno doživljanje telesa (depersonalizacija, dif. dg. cenestetske halucinacije), afektivno je bil nerazgiban, disforičen, do psihopatologije nekritičen, ne pa avto- ali heteroagresiven. Spal je. Logika je izrazito svojska.

Uvedli smo risperidon in lorazepam.

Urin na PAS: negativen za vse testirane substance

Laboratorijski izvidi: MCV znižan (76), eritrociti povišani (5.87), preostale testirani parametri krvi in

urina bp (pacient zanika poseben prehranski režim kot vzrok najdb). Normalno delovanje ščitnice.

EKG odčitan kot normalen, brez ishemičnih sprememb.

CT glave je bil odčitan kot normalen.

Opravili smo klinično-psihološki pregled (povzemam mnenje S. Plakolm / mag. B. Kremžar Jovanović): na podlagi kliničnopsihološkega pregleda ugotavljamo, da gre v osnovi za osebnostno patologijo in posledično za psihotično dekompenzacijo ob stopnjevanju tako situacijskih stresorjev kot notranjih konfliktov. Trenutno je v ospredju preokupacija z odnosi in socialnimi stiki, pri čemer je prišlo, pri sicer socialno umaknjenem in socialno manj spretnem gospodu, do čustvenega preplavljanja in posledično do izgube realitetne kontrole. Gre za gospoda, ki ima le malo socialnih stikov, v odnose vstopa nezaupljivo in previdno. V odnosih je nato hitro prizadet in ima občutek, da se mu godi krivica, zato se jim večinoma izogiba. Njegovo razumevanje socialnih interakcij ter njegove razlage misli in dejanj drugih ljudi so idiosinkratične in pogosto netočne, njegovo procesiranje čustev je izrazito kontrolirano in omejeno, doživljanju in procesiranju čustev se večinoma raje izogne. Aktualno doživlja hud stres, ki ga ne zmore obvladovati. Pričakovati je, da bo tudi v prihodnje ob stresnih situacijah, ki vključujejo socialne situacije, odreagiral z izgubo realitetne kontrole.

Drugi del zdravljenja smo opravili na rehabilitacijski enoti B1, kjer se je sprva motivirano vključeval v oddelčne aktivnosti, ob nižanju lorazepama pa je ponovno postal paranoiden in želel zapustiti bolnišnico s povsem nerealnim načrtom, zaradi česar smo ga selili na varovano enoto in o zadržanju obvestili pristojno sodišče, ki je v nadaljevanju izdalo sklep o zdravljenju brez privolitve do najdlje 29.4.2021. Zadnjih deset dni je bil ob dobrem funkcioniranju ponovno obravnavan na rehabilitacijski enoti, v začetni remisiji, subjektivno zadovoljen.

Opravili smo RTG desne ključnice in CT tega predela po stari poškodbi (nezdravljen zlom, pac. ob poškodbi ni iskal zdravniške pomoči). Travmatologi so na konziliju sklenili, da je indicirano operativno zdarvljenje (prilagamo izvide slikovne diagnostike in konziliarne izvide). Bolniku smo predlagali premestitev na travmatološki oddelek po zaključenem zdravljenju pri nas, s čimer se je strinjal. Opravili smo naročene predoperativne preiskave.

Pac. si je pod vplivom psihotičnega doživljanja povzročil precej socialne škode (odpovedal delovno razmerje, "izgubil" avtomobil v Avstriji, kršil karantenske odločbe). V obravnavo smo vključili socialno delavko in koordinatorja obravnave v skupnosti, ki je pac. na oddelku že obiskal (g. Janez Sterle). Na pacientovo željo smo vzpostavili tudi kontakt z delodajalcem.
Mama in brat sta se informirala o poteku zdravljenja.

Terapevtskih izhodov in obiskov v času zdravljenja ni bilo zaradi omejitev ob Covid-19.

Ob odpustu je sproščen, vedenjsko urejen, četudi svojski, ni produktivno psihotičen, je evtimen, vegetativne funkcije so urejene, je sodelujoč, povsem brez znakov za avto- ali heteroagresivne tendence. Premeščen je na Oddelek za travmatologijo, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju je z naše strani nujno redno ambulantno psihiatrično zdravljenje, datume za kontrolo je že pridobil.

ODPUŠČEN

Splošna navodila ob odpustu
Terapija ob odpustu:
RISPERDAL 2 - 0- 3 mg, eRp.sc.III a 2 mg, sc.III a 3 mg
LORSILAN 2 x 0,5 mg (+ 0,5 mg po potrebi ob nemiru) predvidoma še za čas hospitalizacije in prvih nekaj dni po odpustu, nato naj odmerek zniža na 0,5 mg zvečer za nekaj dni in kasneje prekine jemanje tega zdravila (dokler je v terapiji Lorsilan, ni dovoljeno upravljanje motornih vozil), eRp.sc.I

Hospitalno zdravljenje na našem oddelku je zaključeno.
Bolnika premeščamo na Oddelelk za travmatologijo UKC Maribor zaradi načrtovanega operativnega

posega po zlomu desne ključnice. Izvidi naročenih predoperativnih preiskav so v Medisu, EKG prilagamo. Izvid PCR na SARS-CoV-2 dne 28.4.2021 je negativen.

Bolnik naj po odpustu iz UKC Maribor v lekarni prevzame predpisana zdravila s kartico zdravstvenega zavarovanja.

Psihiatrična kontrola pri dr. Gselmanu (ZD Adolfa Drolca Maribor) 9. 6. 2021 ob 7:30h.
Pac. bo po odpustu sodeloval tudi s koordinatorjem obravnave v skupnosti pri pristojnem CSD (g. Janez Sterle), s katerim je med hospitalizacijo že navezal stik.

MNENJE: Z naše strani predlagamo še vsaj dva tedna aktivnega bolniškega staleža, nato je smiselna prehodna 4-urna delovna obremenitev (predvidoma do kontrole pri psihiatru). Glede na to, da pac. premeščamo na Oddelek za travmatologijo UKC Maribor zaradi načrtovanega operativnega posega po zlomu desne ključnice, bo bolniški stalež odvisen tudi od navodila travmatologa. Odpustno pismo pošljemo izbrani zdravnici (dr. Todorović, ZD Ljubljana Center, Metelkova).

Odpustni zdravnik (lečeči/sobni/dežurni)
PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije

Pacient mora odpustno pismo, ambulantni karton ali drugo medicinsko dokumentacijo izročiti svojemu osebnemu zdravniku ob prvem naslednjem obisku.

V primeru morebitnih naknadnih izvidov sledi Dodatek k odpustnemu pismu.

Spoštovani, vabimo vas, da podate vaše mnenje o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno obravnavo v UKC Maribor tako, da izpolnite vprašalnik. Pripravilo ga je Ministrstvo za zdravje v več jezikih, je anonimen in vam je neprekinjeno dostopen tako, da v svoj spletni brskalnik vpišete: zvem vprašalnik za paciente
Hvala za vaše sodelovanje !